

FONDEMENTS DE LA KINÉSITHÉRAPIE

CONCEPTS GÉNÉRAUX

Cours de révision complet - UFV - Licence en Kinésithérapie

VERSION ÉTUDE : tableaux + explications + schémas conservés

Le contenu du support est conservé. Les pages ci-dessous réorganisent les notions pour faciliter l'apprentissage, tout en intégrant les visuels du support au lieu de les supprimer.

SOMMAIRE

- 1. Qu'est-ce que la kinésithérapie ?
- 2. Qu'est-ce que la rééducation ?
- 3. Histoire de la kinésithérapie
- 4. Domaines d'action des kinésithérapeutes
- 5. Agents physiques
- 6. Fiche de révision

1. QU'EST-CE QUE LA KINÉSITHÉRAPIE ?

Étymologie

KINÉSIS = MOUVEMENT THERAPEIA = TRAITEMENT

La kinésithérapie est donc présentée comme le traitement par le mouvement.

Définition OMS - 1958

« La technique et la science du traitement à travers de : moyens physiques ; exercice thérapeutique ; massothérapie ; électrothérapie. »

La kinésithérapie comprend également :

- tests électriques et manuels pour déterminer le degré d'affectation et la force musculaire
- tests des capacités fonctionnelles
- mesure de l'amplitude du mouvement articulaire
- mesures de la capacité vitale
- aides au diagnostic pour le suivi de l'évolution

Objectifs thérapeutiques OMS

Objectif	Idée à mémoriser
Soulagement	Diminuer la douleur
Circulation	Augmenter la circulation sanguine
Prévention/correction	Prévenir et corriger les dysfonctionnements
Récupération	Récupérer au maximum force, mobilité et coordination

Définitions professionnelles : WCPT, LGS, AEF, APTA et Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña/Madrid

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

KINÉSITHÉRAPIE

« C'est l'un des **pilliers fondamentaux de la thérapie** disposée par la médecine pour **guérir, prévenir et réadapter** les patients. Ces piliers sont la **pharmacologie, la chirurgie, la psychothérapie et la kinésithérapie** ».

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), 1967



KINÉSITHÉRAPIE

« La kinésithérapie est un service fourni uniquement par un kinésithérapeute ou sous sa direction et sa supervision.

Elle comprend l'évaluation, le diagnostic, l'approche, l'intervention et l'évaluation.

*Un mouvement **complet et fonctionnel** est la base même de la santé. »*

World Confederation for Physical
Therapy (WCPT), 1967



KINÉSITHÉRAPIE

*« La kinésithérapie est une **profession de santé** qui se définit comme l'ensemble des méthodes qui, par l'application d'agents physiques, soigne, prévient, rétablit et adapte les personnes souffrant de **dysfonctionnements organiques** et qui exerce ses activités dans le domaine des **soins primaires et spécialisés** ».*

Ley General de Sanidad
(LGS), 1986

KINÉSITHÉRAPIE

« L'ensemble des méthodes, actions et techniques qui, grâce à l'application de moyens physiques et avec le soutien d'autres sciences, soignent, préviennent, rétablissent et adaptent les personnes souffrant de dysfonctionnements somatiques, psychosomatiques et organiques, ou celles qui souhaitent maintenir un niveau de santé adéquat ».

Asociación Española de
Fisioterapeutas (AEF)



KINÉSITHÉRAPIE

« Une profession de santé dont l'objectif principal est la promotion de la santé et du fonctionnement optimal grâce à l'application de principes scientifiques visant à prévenir, identifier, évaluer, corriger ou soulager les dysfonctionnements moteurs aigus ou prolongés ».

“The science of healing. the art of caring: la ciencia de curar. el arte de cuidar”.

American Physical Therapy
Association (APTA), 1989



KINÉSITHÉRAPIE

« La kinésithérapie est une **profession autonome** avec une **identité propre** dans le domaine de la santé, dont l'objectif est de **préserver, rétablir et améliorer le niveau de santé** des citoyens, afin **d'améliorer les conditions de vie des personnes** de la communauté et, plus précisément, de prévenir, promouvoir, **maintenir et rétablir la fonctionnalité** à l'aide des moyens manuels, physiques et chimiques à sa disposition ».

Colegio de Fisioterapeutas de
Cataluña, 1990

KINÉSITHÉRAPIE

« Il s'agit d'une discipline de santé qui offre une **alternative thérapeutique non pharmacologique** qui, dans de nombreux cas, aide à soulager les symptômes de multiples affections, tant aiguës que chroniques. »

Colegio de Fisioterapeutas de
Madrid



2. QU'EST-CE QUE LA RÉÉDUCATION ?

OMS : processus très large comprenant cinq parties principales.

Partie	Contenu
Clinique	Physique et mentale
Psychosociale	Dimension psychosociale
Éducative	Éducation
Professionnelle	Réintégration professionnelle
Récréative	Activités récréatives

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

RÉÉDUCATION

« Comprend toutes les mesures visant à **réduire l'impact** des conditions **d'incapacité et de handicap**, et permet aux personnes touchées par ces processus d'atteindre **l'intégration sociale** ».

Organisation Mondiale de la Santé



Fondements de la Kinésithérapie – Licence en Kinésithérapie – Faculté des Sciences de la Santé – Université Francisco de Vitoria

18

Schéma / visuel conservé du support - page 18

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

RÉÉDUCATION

Il s'agit d'un processus très large comprenant cinq parties principales :

- Clinique (physique et mentale)
- Psychosociale
- Éducative
- Professionnelle
- Récréative

Organisation Mondiale de la Santé



Fondements de la Kinésithérapie – Licence en Kinésithérapie – Faculté des Sciences de la Santé – Université Francisco de Vitoria

19

Schéma / visuel conservé du support - page 19

3. HISTOIRE DE LA KINÉSITHÉRAPIE

Fil directeur

Utilisation implicite des agents physiques depuis l'Antiquité → rationalisation scientifique à l'ère moderne → événements du XXe siècle ayant déterminé la professionnalisation de la kinésithérapie.

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

ÉVÈNEMENTS DÉTERMINANTS

- Utilisation implicite des **agents physiques** depuis **l'Antiquité**.
- **Rationalisation de l'utilisation** de ces agents à **l'ère moderne** grâce au développement de la science.
- Événements du **XXe siècle** qui ont **déterminé la professionnalisation de la kinésithérapie**.

Schéma / visuel conservé du support - page 23

Période / figure	Éléments essentiels du support
Grèce classique - Hippocrate	Séparation médecine/religion ; exercice physique ; héliothérapie ; hydrologie ; massothérapie.
Rome - Galien	Classement des exercices ; massages, exercices et bains ; équilibre des humeurs ; phlébotomie.
Moyen Âge européen	Interdiction des exercices ; traitements religieux, plantes, saignées ; guérisseurs ; amulettes/potions/massages/eaux thermales ; barbier-chirurgien.
XIe-XVe - Monde arabe	Bains thérapeutiques ; Averroès : exercice et massage ; Maïmonide : mouvement et exercice pour rester en bonne santé.
XVIe - Ambroise Paré	Père de la chirurgie moderne ; recommande le massage comme remède thérapeutique.
XVIIIe - Andry	Mot « orthopédie » ; Orthopaedia (1741) ; exercices correctifs infantiles.
XVIIIe - Kratzenstein / Franklin / Galvani / Volta	Expériences électriques ; mouvement de doigts paralysés ; électrothérapie ; bases de neurophysiologie.
XIXe - Zander	Mécanothérapie ; mouvements actifs, passifs, actifs assistés ; appareils orthopédiques.
XIXe - Faraday / Duchenne	Induction électromagnétique ; courants faradiques ; électrodiagnostic ; maladies neuromusculaires ; électrostimulation.
XIXe - Priessnitz / Kneipp	Hydrothérapie moderne ; cures d'eau ; hydrothérapie, phytothérapie, exercice, alimentation, équilibre de vie.
Still / Palmer	Ostéopathie et chiropraxie : thérapies manuelles.
XXe - Klapp / Schroth / Mézières	Scoliose ; correction tridimensionnelle ; chaînes musculaires.
Kabat / Knott	Facilitation neuromusculaire proprioceptive (FNP), innervation réciproque.
Bobath	NDT ; contrôle du tonus ; inhibition des schémas réflexes ; facilitation des schémas moteurs normaux.
Vojta	Diagnostic précoce ; stimulation réflexe de la reptation et du retournement.
Cyriax	Médecine orthopédique moderne ; traitement non chirurgical des tissus mous ; friction transversale profonde.

Période / figure	Éléments essentiels du support
Maitland / Butler / Vodder	Mobilisations oscillatoires ; neurodynamique ; drainage lymphatique manuel.

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

GRÈCE CLASSIQUE

ÉCOLE HYPOCRATIQUE

Hippocrate a séparé la médecine de la religion (V^e-IV^e siècle av. J.-C.).

- Exercice physique
- Héliothérapie
- Hydrologie
- Massothérapie



Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

MÉDECINE ROMAINE

GALIEN

- « *L'enfant prodige qui a écrit trois livres à l'âge de treize ans, mais qui a dogmatisé la médecine pendant environ 1 500 ans* ».
- Il classait les exercices en fonction de leur **intensité**, de leur **durée**, de leur **fréquence**, de l'utilisation d'appareils, etc.
- Il utilisait des agents physiques pour équilibrer les humeurs (massages, exercices physiques et bains).
- Sa méthode était basée sur la phlébotomie.



MOYEN-ÂGE (SIÈCLES V-X)

CHRISTIANISME



Origine de la barre : Les barbiers combinaient leur travail actuel avec des tâches médicales, telles que les extractions dentaires ou les saignées, à l'aide de sangsues.

Les barbiers avaient **deux bâtons** à l'extérieur de leur boutique :

- Un de couleur rouge: ils suspendaient les bandages utilisés et tachés de sang ;
- Un de couleur blanche : ils suspendaient les bandages déjà lavés

Parfois, le vent enroulait les bandages autour des bâtons, créant ainsi le symbole caractéristique des barbiers avec ses couleurs originales : le rouge et le blanc.

MOYEN-ÂGE (SIÈCLES XI-XV)

MONDE ARABE

- Utilisation d'agents physiques, tels que les **bains** à des fins thérapeutiques.
- [Averroès](#) (1126-1198): exercice physique et massage.
- [Maïmonide](#) (1135-1204): mouvement et exercice physique comme piliers fondamentaux pour rester en bonne santé.



SIÈCLE XVI

AMBROISE PARÉ (1510-1590)

- Chirurgien français, considéré comme le père de la chirurgie moderne.
- Premier chirurgien à recommander le massage comme remède thérapeutique.



SIÈCLE XVII

NICOLAS ANDRY DE BOISREGARD (1658-1742)

- Il forge le mot « **orthopédie** ».
- Orthopaedia ou l'art de corriger et de prévenir les déformations chez les enfants par des méthodes qui peuvent être facilement appliquées par les parents eux-mêmes et les personnes chargées de l'éducation des enfants (1741)
- Il **prescrit des exercices correctifs** pour les déformations squelettiques infantiles.



SIÈCLE XVII**CHRISTIAN GOTTLIEB KRATZENSTEIN (1744)**

En **1744**, l'Académie des sciences de Russie avait lancé un concours sur la question de l'utilité de l'électricité en médecine → il remporte ce prix

- IL induit le mouvement des doigts paralysés à l'aide d'électricité
- Naissance de **l'électrothérapie**



Schéma / visuel conservé du support - page 33

SIÈCLE XVIII**LUIGI GALVANI (1737-1798)****Y ALESSANDRO VOLTA (1745-1827)**

- Excitation de l'action musculaire par l'électricité
- Bases de neurophysiologie
- Études sur l'irritabilité et l'excitabilité du tissu musculaire et la physiologie du mouvement volontaire
- Naissance de l'électrothérapie



Schéma / visuel conservé du support - page 35

SIÈCLE XIX

GUSTAV ZANDER (1835-1920)

- Est considéré comme le créateur de la mécanothérapie.
- Il a construit les premiers appareils
 - Appareils de mouvements actifs
 - Appareils de mouvements passifs
 - Appareils de mouvements actifs assistés
 - Appareils orthopédiques



SIÈCLE XIX

MICHAEL FARADAY (1791–1867)

- Il découvre le phénomène de l'induction électromagnétique (1831) et introduit le premier type de courants variables (faradiques).
- Agents physiques



SIÈCLE XIX

DUCHENNE DE BOULOGNE (1806–1875)

- Père de l'électrothérapie
- Électrodiagnostic et traitement des maladies neuromusculaires
- Il établit les bases de l'électrostimulation transcutanée
- Agents physiques



SIÈCLE XIX

ANDREW TAYLOR STILL (1828-1917)

- Père de l'Ostéopathie
- Thérapie manuelle



DANIEL DAVID PALMER (1845-1913)

- Créateur de la Chiropraxie
- Thérapie manuelle



SIÈCLES XX

Rudolf Klapp (1904) : propose un traitement de la scoliose en position quadrupède afin de corriger ou d'arrêter le processus de déformation.

Katharina Schroth (1894-1985) : traitement de la scoliose basé sur trois piliers :

- Correction tridimensionnelle : extension axiale active, déflexion active et dérotation active.
- Fournir une nouvelle valeur de référence.
- Maintien des règles d'hygiène posturale.

SIÈCLES XX



Françoise Mézières (1909-1991) : chaînes musculaires, précurseurs de deux techniques actuelles



Rééducation posturale globale (RPG) de **Philippe Souchard**



Chaînes musculaires de **Léopold Busquet**

SIÈCLES XX

Geoff Maitland (1924-2010)

- Technique de mobilisation ou mouvements passifs oscillatoires.
- Philosophie des soins aux patients : « *Mon concept ne se limite pas à l'application de la technique, mais englobe également l'interrelation profonde entre le kinésithérapeute et le patient ; c'est pourquoi il est difficile de le décrire correctement sans démonstrations cliniques* ».



SIÈCLES XX

David Butler : Mobilisation du système nerveux : traitement neurodynamique.

« Le système nerveux est sans aucun doute impliqué, directement ou indirectement, dans tous les problèmes du patient »

→ Étude et traitement de la mécanique et physiologie du système nerveux (nerfs périphériques, moelle, tronc cérébral).

→ Techniques de mobilisation douce des nerfs pour réduire la douleur et améliorer la mobilité.



SIÈCLES XX

Emil & Estrid Vodder (1896-1986)

Drainage lymphatique manuel

- *« Dans le domaine de la kinésithérapie, le système lymphatique était pratiquement inconnu, une terre sur laquelle il était dangereux de mener des recherches »*
- Il a ouvert la voie à de nombreuses études sur la physiologie lymphatique.



4. DOMAINES D'ACTION DES KINÉSITHÉRAPEUTES AUJOURD'HUI

Spécialités du support	
Orthopédie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Traumatologie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Sport	Domaine d'action de la kinésithérapie
Pédiatrie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Urogynécologie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Esthétique	Domaine d'action de la kinésithérapie
Gériatrie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Neurologie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Cardiaque	Domaine d'action de la kinésithérapie
Respiratoire	Domaine d'action de la kinésithérapie
Rhumatologie	Domaine d'action de la kinésithérapie
Vétérinaire	Domaine d'action de la kinésithérapie
Oncologie	Domaine d'action de la kinésithérapie

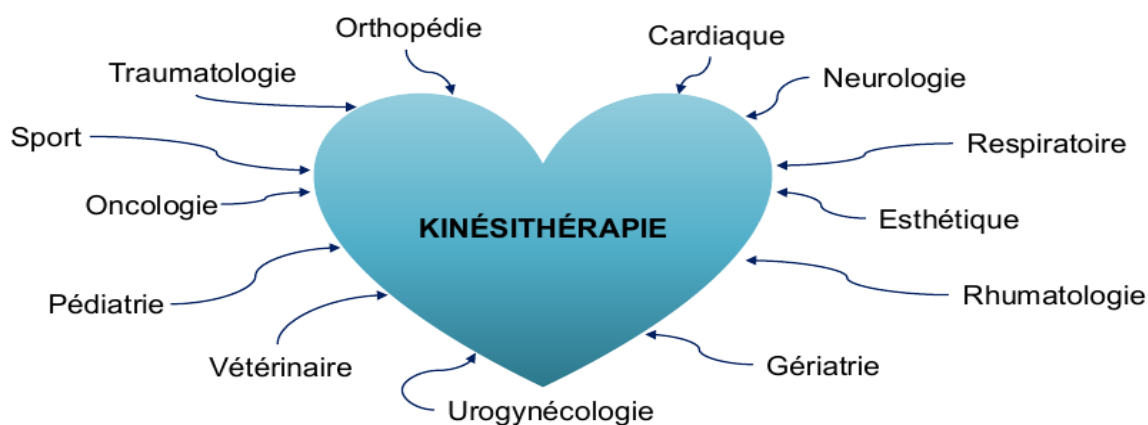
Quatre grandes activités

Activité	Éléments du support
Assistancielle	Relation directe kinésithérapeute-patient ; prévention, guérison/rétablissement ; entretien ; programme ; traitement individuel ou en groupe.
Gestion	Planification ; prévoir la demande ; objectifs ; programmes ; budgets et ressources humaines.
Enseignement	Programmes d'études et formation : université, clinique/hôpital, communauté/société, patient/famille.
Recherche	Approfondir et découvrir de nouveaux domaines ; recherche dans les soins, l'enseignement et la gestion.

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

DOMAINES D'ACTION

SPÉCIALITÉS



DOMAINES D'ACTION

ACTIVITÉ ASSISTANCIELLE

- Relation directe entre le kinésithérapeute et le patient
- Objectif de prévention, de guérison et/ou de rétablissement
 - Entretien
 - Programme de kinésithérapie
 - Traitement individuel ou en groupe

DOMAINES D'ACTION

ACTIVITÉ de GESTION

- Planification professionnelle
 - Prévoir la demande d'assistance
 - Fixer des objectifs
 - Mettre en place des programmes
 - Gérer les budgets, les ressources humaines, etc.

DOMAINES D'ACTION

ACTIVITÉ de PROFESSORAT

- Participation active aux programmes d'études et à la formation :
 - Université
 - Clinique / Hôpital
 - Communauté / Société
 - Patient / Famille

DOMAINES D'ACTION

ACTIVITÉ de RECHERCHE

- Approfondir et découvrir de nouveaux domaines de la kinésithérapie.
- Les activités de recherche couvrent les trois domaines précédents
→ soins, enseignement, gestion.

5. AGENTS PHYSIQUES

Définition du support : énergies et matériaux utilisés pour aider les patients dans leur rééducation.

Catégorie	Exemples / principe	Effets indiqués
Mécaniques	Force : eau/piscine à jets ; traction mécanique ou manuelle ; compression ; ultrasons	Contrôlent la mobilité et modifient la circulation des fluides
Thermiques	Chaleur superficielle (Hot pack) ; chaleur profonde (ultrasons, diathermie) ; froid (Cold pack, petits pois congelés)	Modifient l'inflammation, la circulation sanguine et les réactions chimiques
Électromagnétiques	Courants électriques : TENS, électrostimulation ; champs électromagnétiques : infrarouge, laser, diathermie	Modification des charges électriques tissulaires

Autres classifications citées

- Électrothérapie
- Mécanothérapie
- Cryothérapie
- Hydrothérapie
- Bandages fonctionnels

Caractéristiques

- Faible coût
- Effets rapides
- Adaptables et multiples modes d'application
- Multiples possibilités de traitement

Fondements de la Kinésithérapie – Concepts généraux

AGENTS PHYSIQUES

LEQUELS SONT-ILS ?

Énergie et matériaux utilisés pour aider les patients dans leur rééducation

- Chaleur et froid
- Eau
- Pression
- Sons
- Radiation électromagnétique
- Courants électriques

Fondements de la Kinésithérapie – Licence en Kinésithérapie – Faculté des Sciences de la Santé – Université Francisco de Vitoria 60

Schéma / visuel conservé du support - page 60

AGENTS PHYSIQUES

CLASSIFICATION



AGENTS PHYSIQUES

MÉCANIQUES

Application d'une force par :

- Eau : piscine à jets
- Traction : mécanique ou manuelle
- Compression : bandage élastique, bas
- Son : ultrasons

AGENTS PHYSIQUES

THERMIQUES

Transfert d'énergie au patient :

- Chaleur superficielle : « Hot pack » (compresse chaude)
- Chaleur profonde : ultrasons, diathermie
- Froid : « Cold pack » (compresse froide), petits pois congelés

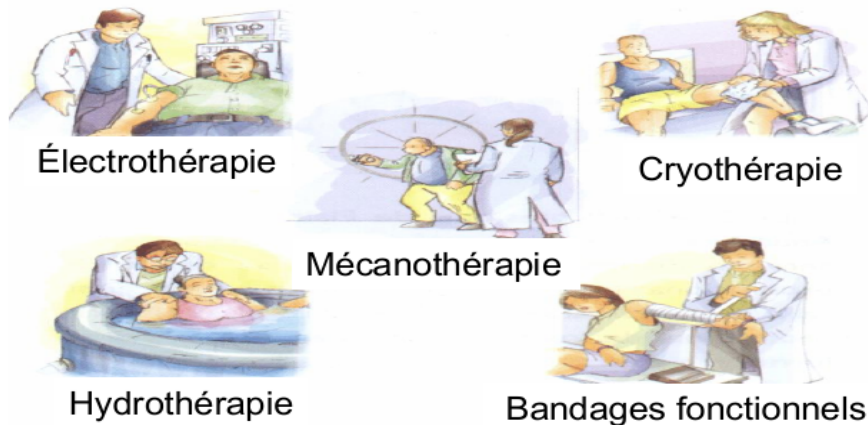
AGENTS PHYSIQUES

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Ressources électriques sous toutes leurs formes :

- Courants électriques : TENS, électrostimulation
- Champs électromagnétiques : infrarouge, laser, diathermie

AUTRES CLASSIFICATIONS...



AGENTS PHYSIQUES

EFFETS

Mécaniques

- Ils contrôlent la mobilité et modifient la circulation des fluides

Thermiques

- Ils modifient l'inflammation
- Ils modifient la circulation sanguine et les réactions chimiques

Électromagnétiques

- Modification des charges électriques tissulaires

AGENTS PHYSIQUES

CONTRAINDICATIONS GÉNÉRALES

- Grossesse
- Pathologie maligne
- Pacemaker
- Altération de la sensibilité
- Altération cognitive

Schéma / visuel conservé du support - page 68

SÉLECTION DE L'AGENT

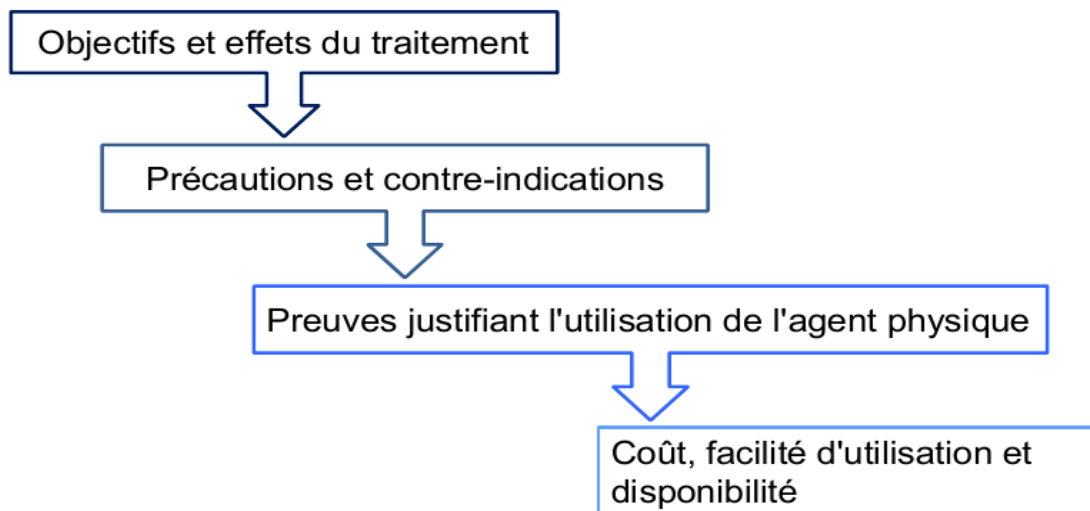


Schéma / visuel conservé du support - page 69



Concepts généraux

91 351 03 03
INFO@UFV.ES
UFV.ES

CTRA. POZUELO-MAJADAHONDA
KM 1.800, 28223 POZUELO DE ALARCÓN
MADRID. ES

Schéma / visuel conservé du support - page 70

Contre-indications générales indiquées dans le support

Grossesse ; pathologie maligne ; pacemaker ; altération de la sensibilité ; altération cognitive.

Sélection de l'agent physique

Critère	Question à se poser
Objectifs / effets	L'agent répond-il à l'objectif du traitement ?
Précautions / contre-indications	Existe-t-il un risque ou une contre-indication ?
Preuves	Les preuves justifient-elles son utilisation ?
Pratique	Coût, facilité d'utilisation et disponibilité sont-ils adaptés ?

6. FICHE DE RÉVISION EXPRESS

À savoir par cœur	Résumé
KINÉSITHÉRAPIE	KINÉSIS = mouvement ; THERAPEIA = traitement.
OMS 1958	Moyens physiques + exercice thérapeutique + massothérapie + électrothérapie.
OBJECTIFS OMS	Douleur ; circulation ; prévention/correction ; récupération force-mobilité-coordination.
RÉÉDUCATION	Clinique, psychosociale, éducative, professionnelle, récréative.
HISTOIRE	Antiquité → science moderne → professionnalisation.
ACTIVITÉS	Assistancielle ; gestion ; enseignement ; recherche.
AGENTS PHYSIQUES	Mécaniques ; thermiques ; électromagnétiques.
SÉLECTION	Objectifs/effets ; précautions/contre-indications ; preuves ; coût/facilité/disponibilité.

CONSERVATION DES SCHÉMAS

Les schémas et visuels du support ne sont pas supprimés : les pages sources correspondantes sont intégrées dans ce document aux endroits où ils servent à comprendre la notion. Le support original comporte 70 pages ; les pages visuelles utilisées proviennent directement de ce support.